

УДК: 614.2

Г.Кулкаева

Министерство здравоохранения и социального развития РК

Внедрение программы управления хроническими заболеваниями в Республике Казахстане

Внедрение в Казахстане Программы управления хроническими заболеваниями (далее – ПУЗ) продиктовано необходимостью серьезных преобразований в вопросах профилактики и борьбы с хроническими неинфекционными заболеваниями в повышении солидарной ответственности пациентов за свое здоровье, улучшения взаимодействия медицинского персонала и использования всех имеющихся ресурсов, направленных на предотвращение возможных осложнений или утяжеления состояний.

Актуальность проблем, вызванных хроническими неинфекционными заболеваниями (далее - ХНЗ) неоспорима. Хронические заболевания представляют серьезную угрозу здоровью населения Европы и всего мира. Они являются важной причиной преждевременной смертности и, поскольку приводят также к инвалидности, существенно влияют на продолжительность полноценной жизни.

Борьба с ХНЗ – одна из наиболее сложных задач, стоящих перед системами здравоохранения. Многие пациенты с хроническими заболеваниями могут жить долго, но при этом нуждаются в постоянной помощи и уходе. Заболевания сердца, инсульты, диабет и рак сегодня являются ведущими причинами смертности и инвалидизации во всем мире. Причины этих заболеваний включают изменчивые факторы риска, связанные с образом жизни, которые возможно изменить. К ним относятся курение, алкоголь, несбалансированное питание, отсутствие или недостаточность физической активности, поэтому без существенных и постоянных вмешательств на уровне политики показатели заболеваемости и смертности в результате хронических заболеваний будут продолжать расти. Хронические болезни поражают все слои населения – от богатых до бедных, от молодых до старческого возраста. В глобальном масштабе от хронических болезней сегодня страдает больше людей, чем от инфекционных, и они ответственны за большую часть бремени болезней в Европе.

Программы по управлению заболеваниями направлены на улучшение здоровья людей с хроническими состояниями и снижение затрат на предотвратимые осложнения путем выявления и лечения хронических состояний быстрее и эффективнее, тем самым замедляя прогрессирование данных заболеваний. В данной программе предполагается скоординировать и интегрировать медицинские вмешательства и коммуникации для определенных групп пациентов с хроническими заболеваниями, где важным компонентом является улучшение самоменеджмента/самопомощи.

Программа управления заболеваниями (ПУЗ) в Казахстане предполагает изменение дизайна медицинского обслуживания в поликлинике с системой «быстрого реагирования» только в момент обращения на проактивную (заблаговременную, предупредительную)

систему ухода за населением, основанную на доказательной медицине. Это включает в себя не что иное, как трансформацию в оказании медицинской помощи. Компоненты ПУЗ, которые должны быть внедрены, сходятся вместе в рамках циклического и непрерывного процесса осуществления ухода в целях оказания медицинской помощи высокого качества, ориентированной на пациентов. В настоящем документе кратко описывается взаимосвязь между компонентами ПУЗ в рамках данного циклического процесса:

- Карты наблюдения за пациентом
- Регистры заболеваний
- Сегментация населения
- Обзвон пациентов
- Запланированные приемы, которые включают

поддержку самоменеджмента.

Карты наблюдения за пациентом являются основным практическим инструментом для оказания поддержки в принятии клинических решений в ходе запланированного приема. Карты наблюдения за пациентом отслеживают оказание ухода в соответствии с описанием в клинических руководствах и являются информацией для различных специалистов, вовлеченных в процесс оказания медицинской помощи. Данные, собранные в карте наблюдения за пациентом во время запланированного приема, вводятся в регистр заболеваний. Карты наблюдения за пациентами являются основным источником сбора данных для формирования регистра пациентов по хроническим заболеваниям.

Данные, собранные в регистрах заболеваний выполняют три функции:

- 1) Отслеживание исходов здоровья населения (отчетность по данным/реестры)
- 2) Сегментирование населения на клинически соответствующие подгруппы для оказания целевого клинического ухода
- 3) Формирование списков пациентов для обзвона в целях проведения регулярных запланированных приемов.

Сегментация населения представляет собой процесс и инструмент для выявления клинически соответствующих подгрупп пациентов, основанных на уровне клинического контроля. В зависимости от уровня контроля пациентов, производится обзвон пациентов в подгруппах для проведения запланированных приемов с различными временными интервалами и оказания ухода в зависимости от уровня контроля пациентов.

Отчетность по данным и реестры представляют собой инструменты исходов здоровья населения с целью мониторинга производительности по внедрению ПУЗ. Индикаторы производительности, заимствованные из клинических руководств, рассчитывается автоматически на основе данных из регистра, и изображаются графически в реестрах с целью предоставить командам возмож-

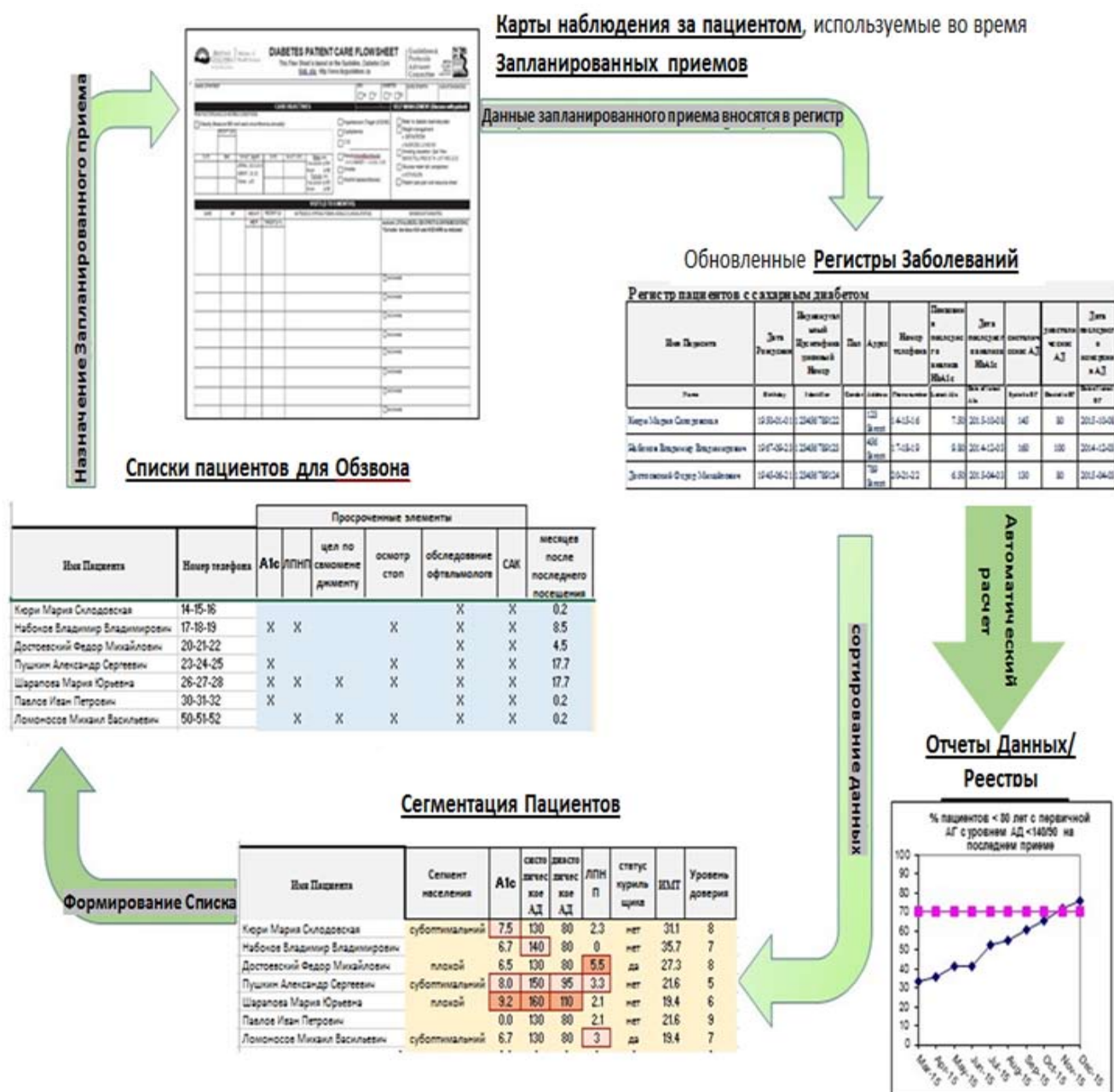


Рисунок 1 - Циклический процесс, необходимый для внедрения ПУЗ

ность просматривать прогресс внедрения.

Обзвон пациентов - это процесс установления контакта и назначения запланированных приемов для подгрупп населения с различными заболеваниями. Подгруппы населения создаются на основе данных из регистров. Системы обзвона пациентов обеспечивают проактивное (заблаговременное) назначение приемов для пациентов в заранее определенные промежутки времени между приемами на основе клинического состояния пациентов. Системы обзвона пациентов могут быть реализованы в колл-центрах, посредством процессов регистрации или при помощи членов мультидисциплинарных команд.

Запланированный прием является механизмом для обеспечения оказания пациентам ПУЗ ухода на основе доказательной медицины. Мультидисциплинарные команды готовятся к приему путем проведения обзора карт наблюдения за пациентом с целью обзора ухода, оказанного во время предыдущего приема. Команды

проверяют, чтобы нужная информация, лабораторное оборудование, и результаты процедур были готовы до приема. В ходе приема пробелы в уходе за пациентом устраняются, а также составляется совместный план ухода, согласованный между пациентом и командой. После приема пациенту назначается следующий запланированный прием. На основе карты наблюдения за пациентом обновляется регистр. Возможные изменения в сегментации подгруппы пациента в связи с изменениями клинического состояния автоматически обновляются в регистре. Затем процесс в рамках ПУЗ начинается снова.

Таким образом, все элементы, реализуемые в рамках Программы управления заболеваниями, циклически взаимосвязаны и взаимозависимы между собой и являются необходимыми для изменения формата оказания медицинской помощи и мониторинга качества предоставления медицинских услуг.